PERÚ Ministerio de Salud

PERÚ PROGRESO PARA TODOS



DIRECTIVA SANITARIA PARA PROMOCIONAR EL LAVADO DE MANOS SOCIAL COMO PRÁCTICA SALUDABLE EN EL PERU

Vivamos el Cambio
Reforma de la Salud

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Promoción de la Salud

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE VIDA SANA

DIRECTIVA SANITARIA PARA PROMOCIONAR EL LAVADO DE MANOS SOCIAL COMO PRÁCTICA SALUDABLE EN EL PERU

Lima, Octubre, 2013

Catalogación hecha por la Biblioteca Central del Ministerio de Salud

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° .....

(c) MINSA, 2013

Ministerio de Salud
Av. Salaverry No 801, Lima11-Perú
Telef.: (51-1) 315-6600
http://www.minsa.gob.pe
webmaster@minsa.gob.pe

Primera Edición, Octubre 2013

Tiraje: 4,000 unidades

Diseño e Impresión: PRYSMA S.A.C
Dirección: Jr. Ica 727 – 2do Piso Lima
Telefax: (51-1) 425 1873

Equipo Técnico
Lic. Liz Marivel Ampudia Ruíz
Lic. Gladys Esther Cusiatado Santiago
Lic. María Elena Flores Ramírez
Psic. María Elena Morante Maco
Dra. Carmen Rosa Quispe Rodríguez
Dr. Eduardo José Rojas Sánchez

Elaborado por:
Dr. Henry Cabrera Arredondo

Secretaria
Srta. Grimaneza Pacheco Ayosa

Versión digital disponible:
http://www.minsa.gob.pe/bvminsa.asp
http://www.minsa.gob.pe/dgps

La presente Directiva Sanitaria para promocionar el Lavado de Manos Social como práctica Saludable en el Perú puede ser citado, total o parcialmente, siempre y cuando se mencione la fuente.

Fotografias tomadas de los archivos fotograficos del Ministerio de Salud.

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Promoción de la Salud

ECO. MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud

DR. JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
Viceministro de Salud

DR. BERNARDO ELVIS OSTOS JARA
Director General de Promoción de la Salud

DR. ROGGER EDUARDO TORRES LAO
Director Ejecutivo de Promoción de Vida Sana

DRA. CARMELA FERNÁNDEZ LOZANO
Jefa del Equipo de la Dirección de Promoción de Vida Sana

MINISTERIO DE SALUD

No. 933-2012/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 24 de SETIEMBRE del 2012

Visto el Expediente N° 11-022283-001, que contiene el Informe N° 026-2012/HCA/DPVS-DGPS-MINSA, de la Dirección General de Promoción de la Salud, los Informes N°s 000455-2012/DSB/DIGESA y 001382-2012/DSB/DIGESA, de la Dirección General de Salud Ambiental, el informe N° 011-2012-DGSP-DSS/MINSA y el Memorando N° 3853-2012-DGSP/MINSA, de la Dirección General de Salud de las Personas, y el Memorándum N° 114-2012-OCS-OGC/MINSA, de la Oficina General de Comunicaciones;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, disponiendo que la protección de la salud es de interés público y por tanto responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, respectivamente;

Que, el artículo 2° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural;

Que, el artículo 60° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA y sus modificatorias, dispone que la Dirección General de Promoción de la Salud es el órgano técnico – normativo, responsable de la conducción del proceso de promoción de la Salud, así como de contribuir en los determinantes sociales que influyen en la salud de la población;

Que, con el documento del visto, la Dirección General de Promoción de la Salud ha propuesto para su aprobación el proyecto de Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el Perú, que tiene como finalidad contribuir a mejorar la salud de la población y a reducir la incidencia de enfermedades infecciosas, mediante la promoción del Lavado de Manos Social como práctica saludable;

J. CRUZADO

E. CASTRO V.

V. CHÁVEZ

D. Suárez

M. De Habich

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Promoción de la Salud,

Con las opiniones favorables de la Dirección General de Salud Ambiental, de la Dirección General de Salud de las Personas y de la Oficina General de Comunicaciones;

Con el visado del Director General de la Dirección General de Promoción de la Salud, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud; y,

De conformidad con lo establecido en el literal l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la DIRECTIVA SANITARIA Nº 095-MINSA/DGPS V.01, "Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el Perú", la misma que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección General de Promoción de la Salud, la difusión de lo dispuesto en la citada Directiva Sanitaria.

Artículo 3º.- Las Direcciones de Salud y las Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel nacional, son responsables del cumplimiento y aplicación de la Directiva Sanitaria aprobada, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 4º.- La Oficina General de Comunicaciones dispondrá la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud

INDICE

Presentación 9

I. FINALIDAD 11

II. OBJETIVO 11

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 11

IV. BASE LEGAL 11

V. DISPOCISIONES GENERALES 12

5.1 Definiciones Operativas 13
5.2 13
5.3 13

VI. DISPOCISIONES ESPECÍFICAS

6.1 De La Técnica Básica para el Lavado de Manos Social. 14
6.2 De los momentos clave para el Lavado de Manos Social. 15
6.3 De las situaciones especiales. 15
6.4 De la importancia del Lavado de Manos Social. 15

VII. Responsabilidades 16

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Promoción de la Salud, es el órgano de línea del Ministerio de Salud y como parte de su misión es brindar los marcos normativos correspondientes a la promoción de prácticas saludables, que promuevan el auto cuidado de la salud de la población.

La presente directiva brinda las disposiciones básicas para la adecuada realización del lavado de manos, los insumos, los procedimientos y los momentos claves para la realización del lavado de manos social. De este modo se facilita que aumente el conocimiento que poseen los ciudadanos y las familias de cuándo y cómo deben realizar la higiene de las manos. La realización o no de una adecuada higiene de las manos tiene consecuencias en la transmisión de agentes patógenos y el desarrollo de enfermedades trasmisibles.

Realizar una higiene de las manos no es simplemente una opción, es una cuestión de sentido común.

El objetivo último es contribuir a la reducción de las enfermedades trasmisibles mejorando la práctica de la higiene de las manos y de este modo ser más eficientes y efectivos en la aplicación de las estrategias sanitarias. Esta Directiva esta diseñada para que pueda ser utilizada por los niveles nacionales, regional y local, es así que los procesos buscan establecer pautas que puedan ser realizadas por todos y todas.

El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas de prevenir enfermedades trasmisibles como son las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias, que son responsables de la morbi mortalidad infantil. Además, previene infecciones cutáneas, infecciones a los ojos, parásitos intestinales, entre otras.

En este contexto la promoción de la práctica del lavado de manos busca hacer incidencia a nivel de los gobiernos del nivel regional y local para que reorienten sus recursos a brindar las condiciones necesarias para que la población y la familia pueda desarrollar la práctica, fomentando la instalación de servicios públicos de agua y desagüe.

El desafío es que el lavado de manos con jabón pase a ser un comportamiento en los hogares, instituciones educativas y comunidades de todo el mundo. Enraizar la práctica del lavado de manos con jabón antes de comer y después de usar el inodoro podría salvar más vidas que cualquier intervención médica.

El hecho de que más personas se laven las manos con jabón podría contribuir de manera significativa a alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de reducir en dos terceras partes de las muertes de niños menores de cinco años para el año 2015.

DIRECTIVA SANITARIA Nº 048 MINSA/DGPS-V.01
DIRECTIVA SANITARIA PARA PROMOCIONAR EL LAVADO DE MANOS SOCIAL COMO PRACTICA SALUDABLE EN EL PERU

I. FINALIDAD

Contribuir a mejorar la salud de la población y a reducir la incidencia de enfermedades infecciosas, mediante la promoción del Lavado de Manos Social como práctica saludable.

II. OBJETIVOS

Establecer las acciones para la promoción del Lavado de Manos Social como práctica saludable en la población.

III. AMBITO DE APLICACIÓN

La presente Directiva Sanitaria, es de aplicación en todos los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales, de EsSalud, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

IV. BASE LEGAL

4.1. Ley Nº 26842 – Ley General de Salud.

4.2. Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud.

4.3. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

4.4. Decreto Supremo Nº 007-2012-SA, que Autoriza al Seguro Integral de Salud, la sustitución del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LRIS) por el Plan Esencial de Aseguramiento Universal.

4.5. Resolución Ministerial Nº 062-2011/MINSA, que dispone Conformar el Comité de Implementación de la Estrategia de Lavado de Manos.

4.6. Resolución Ministerial Nº 111-2005/MINSA, que aprueba los "Lineamientos de Política de Promoción de la Salud".

4.7. Resolución Ministerial Nº 277-2005/MINSA, que aprueba el "Programa de Promoción de la salud en las Instituciones Educativas".

4.8. Resolución Ministerial Nº 457-2005/MINSA, que aprueba el "Programa de Municipios y Comunidades Saludables".

4.9. Resolución Ministerial Nº 402-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Programa de Familias y Viviendas Saludables".

4.10. Resolución Ministerial Nº 720-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Modelo de Abordaje de Promocion de la Salud en el Perú".

4.11. Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA, que aprueba el "Plan Nacional Concertado de Salud"

4.12. Resolución Ministerial Nº 456-2007/MINSA, que aprueba la NTS Nº 050-MINSA/DGSPV.02. "Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo"; modificada con Resolución Ministerial Nº 777-2007/MINSA.

4.13. Resolución Ministerial Nº 193-2008/MINSA, que aprueba la NTS Nº 063-MINSA/DGSPV.01. "Norma Técnica de Salud para la Implementación del Listado priorizado de Intervenciones Sanitarias Garantizadas para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Salud Materno Neonatal".

4.14. Resolución Ministerial Nº 862-2008/MINSA, que aprueba la NTS Nº 074-MINSA/DGSPV.01 "Norma Técnica de Salud que establece el conjunto de intervenciones articuladas para la reducción de la mortalidad neonatal en el primer nivel de atención de salud, en la familia y la comunidad".

4.15. Resolución Ministerial Nº 326-2009/MINSA, que aprueba la Guía Técnica: "Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de influenza por virus A H1N1".

4.16. Resolución Ministerial Nº 478-2009/MINSA, que aprueba la NTS Nº 081-MINSA/DGSP V.01. "Norma Técnica de Salud de los Equipos de Atención Integral de Salud a las Poblaciones Excluidas y Dispersas".

4.17 Resolución Ministerial Nº 702-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Preparando al Agente Comunitario de Salud para el Cuidado Integral de la Salud y Nutrición de las Gestantes y de las Niñas y Niños menores de 5 años".

4.18 Resolución Ministerial Nº 178-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Definiciones Operacionales y criterios de Programación de los Programas estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No trasmisibles, Prevencion y Control de la Tuberculosis y VIH – SIDA y Prevencion y Control del Cancer".

4.19 Resolución Ministerial Nro. 526-2011/MINSA, que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud".

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS

a) Asistencia Técnica [1]: Es el acompañamiento técnico especializado que se realiza al trabajador y equipo de trabajo, caracterizado por la ejecución de acciones de soporte en el que se desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje ligado directamente a un aspecto especifico u operativo del desempeño laboral. Puede estar ligado a la capacitacion o realizarse directamente a solicitud de la instancia regional o local.

b) Consejeria Integral [2]: La consejeria es un proceso de dialogo e interacción entre el consejero y el consultante, generando un espacio educativo, de orientación y apoyo que busca promover cambios de conducta en la persona y su entorno.

c) Lavado de Manos Social [3,4]: Es el lavado de manos de rutina, realizado por la población general usando agua y jabón común, y que tiene una duración no menor de 20 segundos, su práctica permite remover un 80% la flora transitoria[5], y permite la remoción mecánica de suciedad.

d) Presupuesto por Resultados (PpR) [6]: Comprende la aplicación en el ciclo presupuestal, de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y servicios (productos), a ser provistos a un determinado grupo o población objetivo, y los cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados), a ser logrados bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad.

1 Adaptado de la definición establecida en el Plan sectorial concertado y descentralizado para el desarrollo de capacidades en salud 2010 – 2014 (RM Nº 184-2011/MINSA)
2 Adaptado de la definición de Consejería Integral del documento técnico: "Orientaciones para la atención integral de salud del adolescente en el primer nivel de atención", aprobada con RM Nº 1973-2005/MINSA, 2005
3 WHO. Practical Guidelines for infection control in Heath Care facilities, 2004
4 The Healthcare infection control practices advisory committee. Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in healthcare setting 2007.
5 WHO. Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Geneva 2009
6 Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección nacional de Presupuesto Público. "Presupuesto por Resultados: Conceptos y líneas de acción – Documento de Trabajo". Perú, Diciembre 2008

e) Sesiones demostrativas [7]: Son actividades educativas realizadas por el personal de salud capacitado, para inducir el cambio de prácticas de alimentación e higiene, donde los participantes aprenden haciendo. Se aborda aspectos como: Técnicas de preparación de alimentos con productos locales e higiene personal.

f) Sesiones educativas [8]: Son reuniones cortas, no mayores a 40 minutos, dirigidas por personal capacitado, con no más de 20 participantes y que permiten informar, analizar y reflexionar sobre diversos temas de interés , desarrollando contenidos relacionados al logro de prácticas saludables.

g) Trabajo con agentes comunitarios de salud [9]: Es el conjunto de acciones desarrolladas con el agente comunitario de salud para promover acciones comunitarias a favor de la salud y facilitar el proceso, mediante la coordinación con sus autoridades y líderes comunales. Comprende reuniones de análisis, reflexión y monitoreo de las prácticas de cuidado y su refuerzo, acompañamiento y verificación del manejo de información y referencia comunal por parte de los agentes.

h) Visita domiciliaria [10]: Es una actividad extra-mural (fuera del Establecimiento de Salud), realizada por personal de salud capacitado, permite conocer el ambiente en que se desenvuelve la familia, identificar factores de riesgo que influyen en la salud y realizar acciones de información y educación a la familia para la conservación de la salud.

5.2. El personal de salud ejecutará actividades de promoción del Lavado de Manos social, dirigidas a la población general, a través de consejería integral en los Establecimientos de Salud, y Servicios Médicos de Apoyo, y a través de visitas domiciliarias, sesiones demostrativas o sesiones educativas, en la comunidad, adecuando las recomendaciones a sus características culturales.

5.3. El personal de salud, dentro del ámbito de influencia[11] de su Establecimiento de Salud, brindará acompañamiento y asesoría a los docentes, para la incorporación de contenidos relacionados a la técnica básica del Lavado de Manos Social y sobre la importancia de esta práctica saludable, en el Proyecto Curricular Institucional[12], en el marco de los convenios intersectoriales del nivel regional y nacional.

7 *Adaptado de las definiciones establecidas en la NTS Nº 063-MINSA/DGSP V 01. "Norma Técnica de Salud para la implementación del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias Orientadas para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Salud Materno Neonatal", aprobada con RM Nº 150-2008/MINSA.*
8 *Adaptado de las definiciones establecidas en la NTS Nº 063- MINSA/DGSP V 01. "Norma Técnica de Salud para la implementación del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias Orientadas para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Salud Materno Neonatal", aprobada con RM Nº 150-2008/MINSA.*
9 *Adaptado de las definiciones establecidas en la NTS Nº 063- MINSA/DGSP V 01. "Norma Técnica de Salud para la implementación del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias Orientadas para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Salud Materno Neonatal", aprobada con RM Nº 150-2008/MINSA.*
10 *Adaptado de la definición de Visita Domiciliaria del documento Técnico: "Orientaciones para la atención integral de salud del adolescente en el primer nivel de atención", aprobada con RM Nº 1077-2006/MINSA, 2007.*
11 *Ámbito de influencia: Se refiere al ámbito territorial donde los servicios de salud ejercen sus funciones, de acuerdo a los niveles de complejidad y el sistema de conducción y administración, y no corresponde necesariamente a la demarcación político administrativa.*
12 *"Guía técnica de Gestión de Promoción de la Salud en Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible aprobada con RM Nº 290-2011-MINSA*

5.4. El personal de salud, en el marco del trabajo de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS), tes para realizar acciones comunitarias, que favorezcan la promoción y desarrollo de esta práctica saludable, en coordinación con las familia, organizaciones comunales y autoridades locales de su ámbito.

5.5. La programación, ejecución y seguimiento de las actividades para promocionar el Lavado de Manos social, en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, se realizará en función de las necesidades identificadas y según lo establecido en los criterios de programación, de los Programas Estratégicos de Salud, en el marco del Presupuesto por Resultados.

5.6. Los Establecimientos de Salud y los Servicios Médicos de apoyo, reportarán trimestralmente a la instancia correspondiente, las actividades y tareas realizadas, dentro del establecimiento y/o en la comunidad, utilizando el sistema de información regular vigente (Sistema de Información de Salud – HIS).

5.7. Las Gerencias o Direcciones Regionales de Salud, las Direcciones de Salud de Lima Metropolitana y las Redes de Salud, o las que hagan sus veces, promoverán la intervención de sus respectivos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en la planificación, financiamiento y ejecución de proyectos para mejorar los servicios de agua y saneamiento básico, dirigidos a toda la población, y en particular hacia aquella que se encuentra excluida, con la finalidad de mejorar las condiciones para la implementación del Lavado de Manos Social como practica saludable en nuestro país.

5.8. El Ministerio de Salud coordinará con el Ministerio de Educación, en el marco de los convenios vigentes[13], la elaboración, implementación y evaluación de estrategias , contenidos, medios, materiales e instrumentos educativos y comunicacionales para la Promoción del Lavado de Manos Social , así como las disposiciones que faciliten la articulación intersectorial, de Salud y Educación, en el nivel Regional y Local.

5.9. El Ministerio de Salud gestionará el acompañamiento de la Promoción del Lavado de Manos Social, con acciones de comunicación social en salud con enfoque de mercadeo social[14] , con la finalidad de mejorar la salud de la población, mediante la promoción de mejores conductas de higiene. Los contenidos de las campañas comunicacionales serán adaptados a la realidad regional y local, y difundidos por las unidades correspondientes de las Gerencias o Direcciones Regionales de Salud y las Direcciones de Salud de Lima Metropolitana.

13 Convenio Nº 006-2008/MINEDU. Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y sus adendas.
14 Adaptado de Water Engineering and Development Centre (WEDC) and Department for International Development (DFID), "Water supply and sanitation programmes". United Kingdom 1998

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. De La Técnica Básica para el Lavado de Manos Social:

a) Insumos:

- Jabón líquido o en barra.
- Jabonera (debe tener orificios que permiten drenar la humedad del jabón para evitar la acumulación de gérmenes.).
- Agua para consumo humano[15].
- Material para el secado de las manos (papel desechable o tela limpia)

b) Procedimientos:

- Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto.
- Mojar las manos con agua a chorro. Cerrar el grifo.
- Cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta producir espuma, incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas, por lo menos 20 segundos.
- Abrir el grifo y enjuagar bien las manos con abundante agua a chorro.
- Eliminar el exceso de agua agitando o friccionando ligeramente las manos, luego secarlas comenzando por las palmas, siguiendo con el dorso y los espacios interdigitales.
- Es preferible cerrar el grifo, con el material usado para secar las manos, no tocar directamente.
- Eliminar el papel desechable[16] o tender la tela utilizada para ventilarla.

15 Agua para consumo humano. Es aquella agua apta para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluido la higiene personal (Reglamento de la Calidad del Agua para consumo Humano, aprobado por DS Nº 031-2010-SA)

16 La eliminación adecuada del papel desechable se refiere a una correcta disposición de este residuo sólido, en un recipiente donde se almacenen temporalmente los residuos sólidos domiciliarios (Manual de Difusión Técnica Nº 01: Gestión de los Residuos Peligrosos en el Perú. Dirección General de Salud Ambiental. Perú 2005)

6.2. De los momentos clave para el Lavado de Manos Social:

- Cuando las manos están visiblemente sucias.
- Antes de la lactancia materna
- Antes de comer.
- Antes de manipular los alimentos y cocinar.
- Antes y después de cambiar los pañales a las niñas y los niños.
- Antes y después de atender familiares enfermos en casa.
- Después de usar el baño para la micción y/o defecación.
- Después de la limpieza de la casa.
- Después de manipular animales.
- Después de tocar objetos o superficies contaminadas (Ej. Residuos sólidos, dinero, pasamano de las unidades de servicio de transporte, etc.).

6.3. De las situaciones especiales:

En caso de no tener agua de consumo provista mediante un grifo, se utilizara un recipiente previamente lavado, que al ser inclinado deja caer una cantidad suficiente de agua a chorro para lavar y enjuagar las manos.

En caso de no disponer de jabonera, se utilizará un recipiente que haga las veces, y que permita drenar la humedad del jabón para evitar la acumulación de gérmenes.

Es importante que el Ministerio de Salud, las Gerencias o Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Salud de Lima Metropolitana resalten la importancia de priorizar la inversión de los Gobiernos Regionales y Locales, en la instalación de servicios públicos básicos de agua y desagüe, para toda la población y especialmente para aquella que aún se encuentra excluida.

6.4. De la importancia del Lavado de Manos Social:

Se considera que las manos actúan como vectores, portadores de organismos patógenos causantes de enfermedades contagiosas, ya que a través del contacto directo, o indirectamente por contacto con superficies contaminadas (Wagner y Lanoix)[17]

El lavado de manos social, usando agua para consumo humano y jabón, previene los dos síndromes clínicos que causan el mayor número de muertes infantiles a nivel mundial, es decir, la diarrea y las infecciones respiratorias agudas bajas[18].

El lavado de manos también puede prevenir infecciones cutáneas, infecciones a los ojos, parasitosis, síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), la gripe aviar y la influenza A H1N1, y trae beneficios a la salud de las personas que viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA)[19]. El lavado de manos con jabón es la intervención de salud más eficaz y costo-efectiva (Jamison et al. 2006); por cada US$3.35 que se invierte en los programas de lavado de manos, se gana un Año de vida Ajustado en función de discapacidad (AVAD).

17 Día Mundial del Lavado de Manos 15 de Octubre. Guía para Facilitadores 2ª Edición. www.globalhandwashingday.org Julio 2009.
18 Luby S. P. Agboatwalla M. Feikin D. R. Painter J. Billhimer W. Altaf A. Hoekstra R. M. Effect of handwashing on child health: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 225-33.
19 Día Mundial del Lavado de Manos 15 de Octubre. Guía para Facilitadores 2ª Edición. www.globalhandwashingday.org Julio 2009.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1. A nivel nacional

El Ministerio de Salud, a través de la dirección General de Promoción de la Salud, es responsable de la difusión de la presente Directiva Sanitaria hasta el nivel regional; así como de la supervisión, monitoreo y evaluación, de las acciones desarrolladas por el nivel regional en aplicación de lo dispuesto; asimismo, brindara la asistencia técnica para el cumplimiento de la presente Directiva Sanitaria.

7.2 A nivel regional

Las Gerencias o Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Salud de Lima Metropolitana, o las que haga sus veces, serán responsables de supervisar, monitorear y evaluar la implementación de lo dispuesto en la presente Directiva Sanitaria, en todo su ámbito de influencia así como de brindar la asistencia técnica correspondiente.

7.3 A nivel local

La intervención de las Redes, Micro Redes, Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, para la aplicación de lo dispuesto en la presente Directiva Sanitaria se hará en coordinación con las Gerencias o Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Salud de Lima Metropolitana, o las que hagan sus veces.

Av. Salaverry Nº 801 - Jesus Maria - Lima
Telefono: 01-315-6600
Web Site: www.minsa.gob.pe
Infosalud 0800 -10 -828

